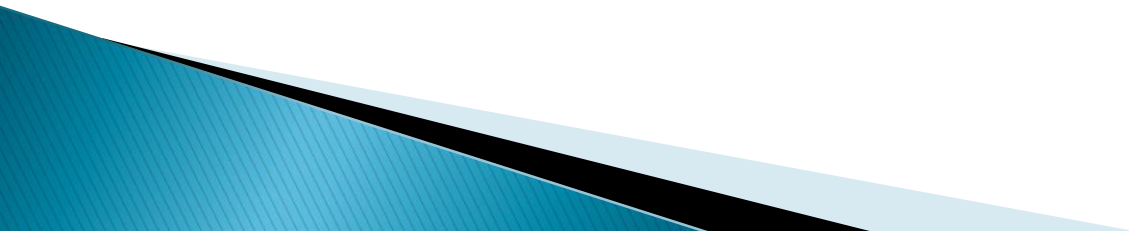


不安症群・強迫症および関連症群・ 食行動障害および摂食障害群

名古屋市立大学大学院
人間文化研究科
小川 成

1. 不安について



1. 不安・恐怖は有益である

(1) 危険警報

● 不安・恐怖は危険の回避のために有益

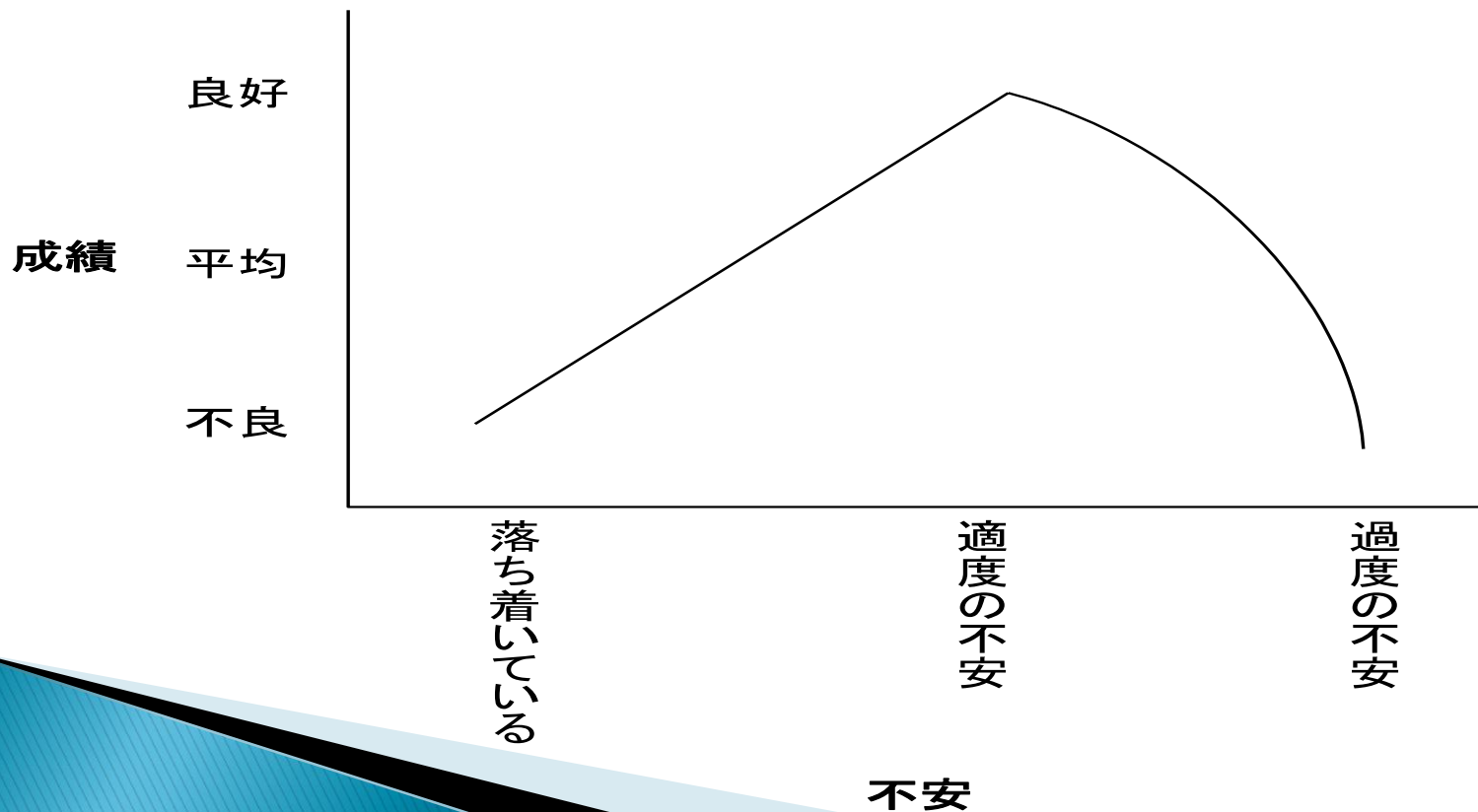
＊ 危険を知らせるアラーム

＊ (例) バスが突進してきて目の前まで迫ってきた
→ 恐怖感・不安感[↑] → 走って逃げる

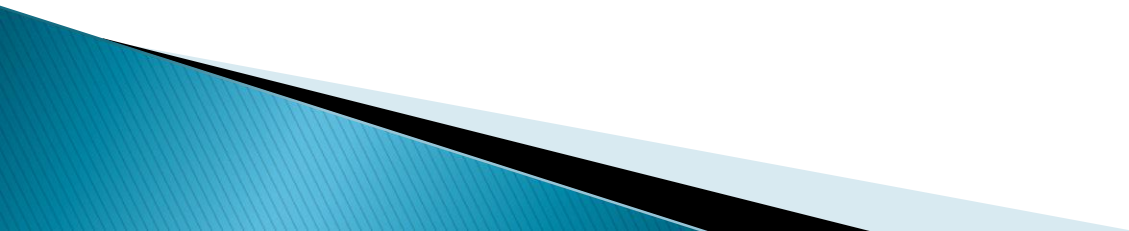
● 逃げるか戦うか反応: 不安・恐怖により呼吸数や心拍数を増やすなど危険に対処しやすくなるような身体反応が起きる

(2) 効率アップ

● ヤーキーズ・ドットソン曲線
⇒ 適度な不安は効率を上げる



2. 不安症群(不安障害群)



2. 不安症とは

①概念

- 不安症：過剰な恐怖および不安、それらに関連する著しい行動上の障害（回避行動など）

②特徴

- 有病率が高い
- 現実検討力が著しく障害されていない
- うつ病や双極症（躁うつ病）などの合併が多い

3. 不安症の生物学的要因

●複数の脳部位(**扁桃体**、前頭皮質、線条体、視床)の**過活動**によって生じる

＊いずれの脳部位もセロトニンが抑制性の神経伝達物質で、不安症では**セロトニンが不足した状態**

⇒**SSRI**が症状軽減に有効

1. パニック症

(1)概念

●パニック症：**予期しないパニック発作の反復**により予期不安や発作に関連した著しく不適応な行動上の変化が生じる病態

＊パニック発作が2回以上起こったことが必要。

●診断：てんかん発作（特に自律神経発作）、甲状腺機能亢進症との鑑別が必要

＊頭部画像、脳波、甲状腺ホルモン等の検査は必須

●経過：数年に渡って再発なしに完全寛解する例は稀

(2)パニック発作(≠パニック症)

①概念

●パニック発作:強い不安感から来る**自律神経(交感神経)症状**で、**突然発現**し数分以内にピークに達する

●診断基準(DSM-5)では**下記13項目のうち4つ以上あるとパニック発作**

***動悸**、発汗、身震い、**息苦しさ**、窒息感、胸痛、**嘔気**、**めまい感**、寒気または熱感、異常感覚、**現実感消失**、コントロールを失う恐怖、死ぬ恐怖

②パニック発作の特徴

- パニック発作は一時的な自律神経の乱れから来るものなので**長時間は持続しない**

＊ただ、経験した人によるとかなりの苦痛らしい・・・

- 心理的ストレス**のほか**身体的不調**(カフェイン過剰摂取、睡眠不足等)によっても起きる

- 健康な人でも**40%の人**は一生涯に1回は経験する

＊パニック発作自体は病気ではない

(3) パニック症の症状の形成過程

予期しないパニック発作の反復



発作がいつどこで起こるかわからない状態



予期不安(「また発作が起こるのではないか」)
行動上の不適応な変化(広場恐怖など)

パニック症の症例(医師国試より)

26歳女性。突発する動悸、めまい、過呼吸等を主訴に受診。症状は3カ月前に地下鉄に乗車中に起こり、その後同様の症状をたびたび経験するようになった。同時に「このまま死んでしまうかもしれない」という恐怖感に襲われる。ふだんでも「また発作が起きるんじゃないか」という考えにもとらわれている。採血、心電図、胸部単純写真、頭部MRI、脳波等の諸検査では異常なし。最近では地下鉄に乗るのがこわくてバスなど別の交通機関を利用している。

(4) 疫学

●有病率(日本)

生涯有病率:0.8% 12か月有病率:0.3%

＊欧米諸国では、12か月有病率は2～3%

●性差

女性は男性の約2倍

●発症年齢

中央値は20～24歳

●併存症

50～65%がうつ病を併存

(5)治療

●患者さんに伝えておくべきこと

「パニック発作では死なない」

「パニック発作は必ず治まる」

●薬物療法

SSRI

三環系抗うつ薬(イミプラミン、クロミプラミン)

●心理療法

支持的精神療法

認知行動療法

2. 広場恐怖症

(1) 概念

● 広場恐怖症：何かあっても**逃げられない、助けてもらえない**ような状況を恐れ、回避する

＊「何か」：尿意や便意、パニック発作など自分で制御困難な身体症状

＊6カ月以上の持続期間が必要

●「広場」：公共の場所→逃げ出しにくい場所

＊地下鉄、電車、飛行機、映画館、教室など

＊「逃げ出しにくい」繋がり、高速道路、橋、トンネル、列に並ぶなど

(2)疫学

●有病率(日本)

生涯有病率:0.2% 12か月有病率:0.1%

●性差

女性は男性の約2倍

●発症年齢

平均21歳、3分の2は35歳以前の発症

●併存症

パニック症の20～80%に併存

●予後:完全寛解は10%

(3)治療その他

●治療：パニック症に準じる

＊薬物療法：**SSRI**など

＊認知行動療法も有効

●その他

広場恐怖症は、2013年のDSM-5診断基準改定時に独立した疾患として認められた

＊病因や病態については研究途上

＊改定前はパニック症の随伴症状という位置づけ→「広場恐怖を伴うパニック症」

3. 社交不安症

(1) 概念

● 社交不安症：人前で行動する際に、恥をかいたり軽蔑されたりするのではないかと恐怖感を抱き、対人場面を回避してしまう病態

- * 他人からの否定的評価への恐怖感が根底にある
- * 自分の恐怖が過剰かつ不合理であることは認識
- * 6カ月以上の持続期間が必要

(2)疫学

●有病率(日本)

生涯有病率:1.4% 12か月有病率:0.7%

＊欧米では4～16%、韓国0.5%、台湾0.6%

●発症年齢

中央値13歳、75%は8～15歳で発症

●経過

人間関係に著しい支障を来し、学業や就労に大きな影響を及ぼすほか、独身者が多い

●併存症

うつ病、物質関連症群

社交不安症の症例(国試より)

45歳男性。「会社に行きたくない」と言って来院。10歳ころから人前で食事をしたり話をしたりするのが極端に苦手になった。就職してからは周囲から見られているようで電車での通勤がつかつたとのこと。最近部長に昇格し朝礼の司会をしなければならなくなった。このことがつらくて、会社を辞めようと思うとのこと。

(3)治療

●藥物療法

SSRI

●心理療法

支持的精神療法

認知行動療法

4. 限局性恐怖症

(1) 概念

●限局性恐怖症：はっきりと限定された状況や対象に対する恐怖

＊（例） **高所恐怖**、閉所恐怖、動物恐怖、血恐怖・・・

＊6カ月以上の持続期間が必要

＊生活に支障が出るレベルかどうかが診断のポイント

(2)疫学

●有病率(日本)

生涯有病率:3.4% 12カ月有病率:2.3%

＊12カ月有病率は米国では8～12%

＊不安症の中では最も頻度が高い

●性差

女性は男性の約2倍

●発症年齢

平均発症年齢は10歳

●予後

自然寛解もありえるが、成人まで症状が残存すると多くは寛解困難

(3)治療

●心理療法

曝露療法

＊(例)高所恐怖なら、少しずつ高いところに慣れてもらう

5. 全般不安症

(1) 概念

●全般不安症：日常生活や仕事などの多くについて過剰な不安を呈する病態

＊不安のほか、集中力の低下、**易怒性**等の症状

⇒不安に起因する雑多な症状が見られる

＊**自律神経症状**(頭痛、めまい、不眠など)も呈する

＊6か月以上持続している状態

(2) 疫学

●有病率(日本)

生涯有病率:2.6% 12カ月有病率:1.2%

＊12カ月有病率は米国では9.0%

●性差

女性は男性の約2倍

●発症年齢

北米における平均発症年齢は35歳

●経過

生涯を通じて慢性的・波動的。完全寛解率は非常に低い

全般不安症の症例

49歳 女性 主婦。主訴はいろんなことが心配。

昔から心配症で、「考えすぎ」とよく人から言われていた。1年前に夫が検診でコレステロールが高いと言われ、食事に気を付けるようアドバイスを受けたところ、食事のせいで心臓発作が起こったら自分のせいだと心配して献立に異常に気を使うようになった。

また、肩こりや後頭部を中心とした頭痛もしばしばあった。疲れやすくめまいもあるので、外出も億劫である。日中もリラックスできず翌日のことが気になってしまい、寝つきも悪い。

（「NEW精神医学」より）

(3)治療

●藥物療法

SSRI

SNRI

●心理療法

認知行動療法

支持的精神療法

6. 分離不安症

(1) 概念

●分離不安症：母親など愛着のある人物との分離に関して過剰な不安を感じ、精神・身体症状を惹起することにより機能障害に至る

●症状

分離に関する過剰な苦痛や恐怖、不登校などの回避行動、身体症状、分離に関する悪夢など

＊児童や青年では4週間、成人では6か月以上持続

(2)疫学

●有病率(米国)

12か月有病率: 児童で4.0% 成人で0.9~1.0%

●好発年齢: 7~8歳

* 以前は18歳以前に発症することが要件であったが、成人発症も見られる

* 成人の77.5%は成人期に発症

●80%以上の患者が不安症や気分障害、物質使用障害を併存

(3) 治療その他

- 治療

個人精神療法、家族療法など

- DSM-5から不安症に分類

＊成人発症も認められるようになったため
(以前は児童・思春期の疾患に分類)

7. 場面緘黙

(1) 概念

●場面緘黙：話す能力はあるが、**学校などの特定の社会状況では声を出して話すことができない病態**

＊家庭では普通に話せるが、学校では黙ってしまう

＊学業や職業、人間関係に支障が出る程度

＊1か月以上の持続期間も

(2)疫学

- 有病率は1%未満(米国)
- 3歳前後の幼児期から発症
- 経過は様々だが、**比較的良好。多くの患者は自然に改善する**
- 選択性緘黙の患者のほとんどは不安症状(特に社交不安症状)を有することから、DSM-5から不安症に分類されることとなった

(3)治療や対応

●治療

積極的な治療が必要でない場合も多い

＊非言語的心理療法(箱庭療法、絵画療法)、家族療法、行動療法

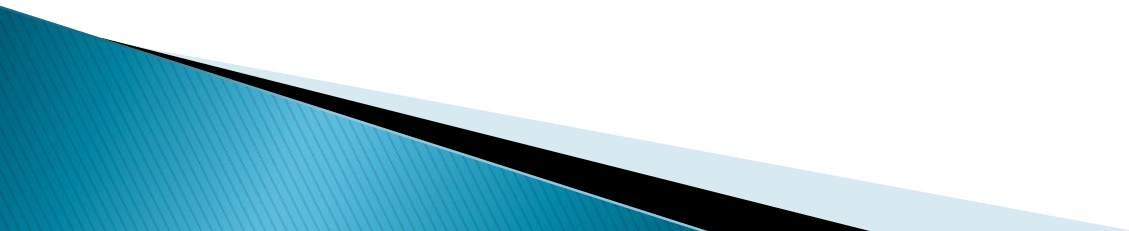
●対応

無理に話をさせようとするのは厳禁

＊患児は緘黙することで不安感や緊張感から自身を防衛している

＊教室で孤立しないよう配慮

3. 強迫症(強迫性障害)および 関連症群



1. 強迫症

(1) 概念

● **強迫観念**や**強迫行為**等の症状により、重大な苦痛または機能障害が生じている病態

＊ 強迫観念や強迫行為の不合理性は自覚している

● 以前は不安症(不安障害)の一つとされていたが、DSM-5では別のカテゴリーとなった

＊ 近年の脳画像研究の結果により、他の不安症とは区別されるという意見が強くなったため

(2)強迫観念と強迫行為

①強迫観念

●**強迫観念**：繰り返し頭に浮かんでくる無意味な観念、思考、イメージ

＊「考えまい」と努力しても余計ひどくなる

●ウェグナーの思考抑制実験

「白クマについて考えないように」と被験者に指示

→考えないようにしようとする、かえってその考えにとらわれてしまう

②強迫行為:

●**強迫行為**:強迫観念による苦痛や不安を緩和・予防するために過剰かつ反復的に出現する行動

＊(例)何回も手を洗う 火の元、戸締りを何回も確認する など

＊同居の家族を強迫行為に巻き込む場合がある

＊強迫行為には**強迫観念により起きた不安感を軽減する作用**があるため、これが強化となり学習が起きやすい

(3)強迫症状の類型

	強迫観念	強迫行為
汚染に対する強迫	ドアノブは不潔ではないか	ドアノブを触ったあと頻回に手を洗う
疑念を内容とする強迫	鍵をかけたのを忘れてないか	施錠したかどうか何回も確認する
侵入的な強迫観念	人前で卑猥な言葉を言ってしまうのではないか	(強迫行為はない)
対称性や正確性に対する強迫	(電柱や窓の数が気になる)	電柱や窓の数を数える

強迫症(例1)(医師国試より)

30歳女性。昨年第一子出産後、赤ん坊に汚れがついてはいけなと過剰に考えるようになった。

外出から帰ってくると、すぐ衣類を着替えて洗濯し、家の中の全てを毎朝消毒しないと気が済まないようになってきた。

自分でもおかしいことはわかっているが、どうしてもやめることができない。最近では夫も消毒につきあわされて閉口している。

強迫症(例2)(医師国試より)

27歳男性。物事を何度も確認しないと安心できないと訴えて来院した。

高校時代に字を書いても計算をしても間違いの有無を調べ続けるようになった。

その後さらに対象が広がり、鍵やガス栓の点検を何度も繰り返すようになった。このため何事にも時間がかかり、本人も疲れて職場にも毎日遅刻するようになった。

(4)生物学的要因

●複数の脳部位(前頭皮質、線条体、視床)の過活動によって生じると考えられている

＊扁桃体の関与は大きい

＊いずれの脳部位もセロトニンが抑制性の神経伝達物質で、セロトニンが不足している状態

⇒SSRIが症状軽減に有効

(5) 疫学

●有病率

12カ月有病率:1.2%(米国)

●性差

児童期では男子が、成人期では女性が多い

●発症年齢

平均発症年齢は20歳前後(米国)

●経過

通常は慢性的な経過。寛解率は20%

(6)治療

●薬物療法

三環系抗うつ薬

SSRI

●心理療法

行動療法(曝露反応妨害法):不安対象に曝露してその反応を妨害する

＊(例) 汚いものに触る→手を洗いたくなる→がまん

＊ほかに**森田療法**(あるがままに症状を受け入れ、やるべきことをやりつつ症状へのとらわれを減少させることを目指す)

2. 身体醜形症

(1) 概念

●身体醜形症：身体的な外見に関する1つ以上の欠陥または欠点への**過剰なとらわれ**とその反応としての**繰り返し行為**が見られる病態

＊欠陥または欠点は他人からはわからないことがほとんど

●症状：鏡を見る 過度に手入れをする 皮膚をひっかく など

＊皮膚科や歯科、美容外科等の受診を繰り返す

(2)疫学

●有病率

成人の時点有病率は2.4%(米国)

＊皮膚科患者の11～13%、形成外科患者の7～8%

●発症年齢

3分の2は18歳までに発症。平均発症年齢は16～17歳

＊高齢での発症はほとんど知られていない

●経過

美容外科的介入の効果は一時的である場合が多い

＊介入により予後が悪化することもある

(3)治療

＊確立された治療法はない

●薬物療法

SSRI 三環系抗うつ薬 抗精神病薬

●心理療法

認知行動療法

3. ため込み症

(1) 概念

●**ため込み症**：過剰に物を集め整理できず捨てられないために生活空間に物があふれ生活ができなくなる病態

＊「ゴミ屋敷」の住人はこの疾患の可能性がある

●**要因**：優柔不断さ、対象物への情緒的愛着

＊以前は強迫症の一亜型とされていたが、DSM-5では独立した疾患となった

(2)疫学・治療

①疫学

●有病率

成人の時点有病率は1.5～6% (欧米)

●発症年齢

15～19歳で発症。

●経過

症状が徐々に重症化し慢性的に持続

②治療

SSRI 抗精神病薬 認知行動療法

＊有効性は確立されていない

4. 抜毛症(抜毛癖)

(1) 概念

- 自分の体毛(頭髪、眉毛、まつ毛)を反復的に抜くことで、その部位の体毛が喪失してしまう病態
 - * 抜毛をやめようとするができない状態
 - * 臨床的に重大な苦痛を呈する、あるいは社会的・職業的に著しい障害を呈する
 - * 小児期の一過性の抜毛は良性の習慣ととらえ、病的とは判断しない

(2)疫学・治療

①疫学

●有病率

12カ月有病率は1～2%(米国)

●性差

1:10で女性に多い

●経過

思春期以降に発症し慢性的に持続

②治療

SSRI 抗精神病薬 認知行動療法

＊有効性は確立されていない

5. 皮膚むしり症

(1) 概念

● **自分の皮膚を反復的に掻きむしることで、その部位が損傷してしまう病態**

* 掻きむしりをやめようとするができない状態

* 臨床的に重大な苦痛を呈する、あるいは社会的・職業的に著しい障害を呈する

(2)疫学・治療

①疫学

●有病率

生涯有病率は3.1%(米国)

●性差

75%は女性

●経過

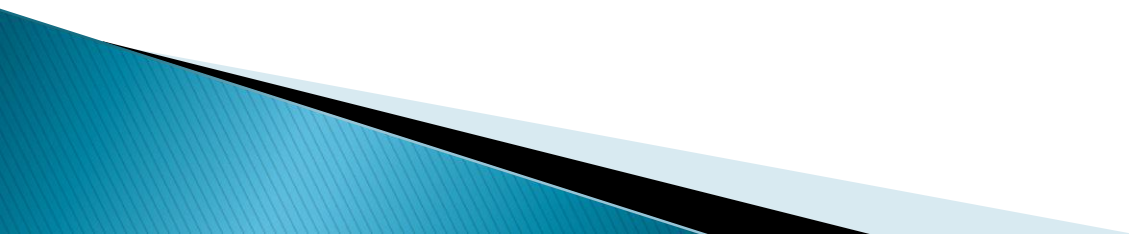
思春期以降に発症し慢性的に持続

②治療

SSRI 抗精神病薬 認知行動療法

＊有効性は確立されていない

4. 食行動症および摂食症群



1. 摂食症とは

①概説

●摂食症

心理的背景をもつ食行動の障害。**過食**もしくは**拒食**に陥る。**Body Imageの障害**が基盤にある

●Body Image

自己の身体とその属性についてのイメージ

⇒摂食症患者は、体重や体型により自己評価が大きく影響されるため、現実にはやせているのにそれを認めることが難しい(Body Imageの障害)

②病因・病態

●心理的要因

女性性の拒否、成熟拒否、家族内の葛藤など

●遺伝・環境要因

神経性やせ症(拒食症)は遺伝的要因強い

2. 神経性やせ症(Anorexia Nervosa: AN)

(1)概説

- 心理的要因からくる拒食により、るいそうを来した病態

 - ＊るいそう:病的にやせていること

- 古くから症例報告があり、「やせてるほうが美しい」という価値観がなくても出現する

●むちゃ食い・排出型と摂食制限型がある

●むちゃ食い・排出型

過食のほか、自己誘発嘔吐、下剤使用などの代償行動が見られる。衝動性が高い人が多い

＊代償行動の影響

嘔吐による齲歯、嘔吐・下痢による低カリウム血症

(1) 症状

- **著しい低体重・体脂肪の減少**

⇒ **月経不順**や徐脈、低血圧、便秘、低体温などを併発

＊BMI 17～18 が一つの目安

- **肥満恐怖**：低体重であっても体重を増やしたくないと強く思う

＊嘔吐や下剤の乱用など体重増加を妨害する行動

＊嘔吐や下痢による**低カリウム血症**も頻発

●Body Imageの障害

低体重の深刻さを理解できず、**病識は乏しい**

＊100g体重が増えただけで希死念慮に至ることも
→自己評価低く、うつ病を合併しやすい

●**活動性は高まっていて**学業やスポーツ等に打ち込む
⇒空腹の結果活動性が増加されている

＊ラットは絶食させられるとより長時間車回しを続け、
これにより体重減少が進んでも走り続ける場合がある
(Routtenberg, 1968)

神経性やせ症の症例(医師国試より)

18歳女性。体重減少を心配する母に付き添われて来院。14歳のとき友人から「あなたは太っている」と言われ悩んでいた。半年前から食事の量が減り、現在までに体重が12kg減少した。患者は活動的であり、まだ太り過ぎていると考えている。3カ月前から月経がない。

現在の身長は164cm、体重は34kg。

(2) 疫学・経過

① 疫学

- 90～95%は若い女性

- 女性の生涯有病率0.9%

- ＊ 受診率が低いため調査が困難

② 経過

- 経過は様々だが多くは長期の経過

- ＊ 20～30%は神経性過食症へ移行？

- 生命予後は良好ではない

- ＊ 10年ごとに5%が死亡（餓死、自殺が多い）

(3)治療

①身体面の治療

＊再発しやすく長期の治療が必要

●体重減少が軽度な場合

外来通院で食事内容・生活を見直す

＊1日250～300kcal増やす、1日5食にするなど

＊過剰な運動をやめさせる

● 極端な低栄養状態の場合

入院加療による強制的な栄養投与

＊効果は一時的で体重の維持は困難

● 再栄養症候群: refeeding syndrome

栄養摂取が急激な場合に、糖質の細胞内への移動や代謝の促進によりリンが大量に消費され、**リン不足**になるために起きる

＊心不全をきたすと致命的

⇒入院による強制的な栄養投与の際には要注意

②心理面の治療

- ＊ 確立されたものはない
- ＊ 薬物療法も余り効果ない

●心理療法

折衷的・統合的アプローチにより**低い自己評価にはたらきかける**

- ＊ 極端なうしろ状態（入院直後等）ではやらない
- ＊ 長期的なフォローが必要
- ＊ **家族療法**→背景にある**家族間の葛藤**に介入

3. 神経性過食症(神経性大食症) (Bulimia Nervosa : BN)

●発作的にむちゃ食い(**過食**)を繰り返す病態で、自己誘発嘔吐などの排出行動を伴う

＊排出行動を伴わない場合は**むちゃ食い症**となる
→多くは肥満・過体重

●現代病である

即座に食物が手に入り過食嘔吐できる私的空間がある社会でのみ成立する病態

(1)症状

●過食、その後排出行動

→やせ型から肥満体まで体型はさまざま

＊過食用の大量の食べ物を入手するため窃盗も見られる

＊日中は絶食し夜間に過食することで昼夜逆転の生活になることもある

●過食は自分ではコントロールできない

→途中で止められる場合は過食と判断しない

●Body Imageの障害

体重や体型で自己評価が決まる

＊過食してしまうと落ち込んだり自己嫌悪
→うつ症状が主訴で受診する場合もある

＊病感や病識はある

●週1回以上の過食や排出行動が3か月続く

＊DSM-5-TRの基準

●活動性は低下する

神経性過食症の症例(医師国試より)

25歳女性。過食と嘔吐があるため母親に連れられて来院。1年前から短時間に大量の食べ物を摂取しては口に指を入れて嘔吐するというのを週に2～3回繰り返している。過食をすると自己嫌悪して気分が落ち込む。体重は変動するが極端な低体重には陥っていない。無月経でもない。

(2)疫学・経過

①疫学

- 成人女性に好発
- 女性の生涯有病率1.5%
- * 受診率が低いため調査が困難

②経過

- 10～20%が慢性化
- * 神経性やせ症への移行はほとんどない
- 生命予後は良好ではない
- * 10年ごとに2%が死亡(餓死、自殺が多い)

(3)治療

①概説

●治療のターゲットはむちゃ食い・排出行動
→少しずつコントロールするのが原則

●むちゃ食い・排出行動以外にも注目する必要
＊日中の絶食状態、睡眠不足など

②心理的治療

●認知行動療法

むちゃ食い・排出行動の際に感じる自己嫌悪やうつなどの感情を把握し、その背景にある認知(思考)にアプローチしていく

＊エビデンス高い

●NICEガイドラインでは、治療の第1段階はワークブックによるセルフヘルプ

＊内容は、病気の理解、生活の規則化など

③薬物療法

●抗うつ薬

SSRIは抑うつの改善を介さずむちゃ食いに直接効果を発現するとされる

＊長期的な効果は不明

＊NICEガイドラインでは補助的な位置づけ

4. 食行動症

(1) 異食症

- 非栄養、非食物の物質を1か月以上摂取する
 - * 乳幼児がいろいろなものを口に入れることや文化的慣習などは除く
- 女性と子供に多い
- 明確な治療法はない

(2)回避・制限性食物摂取症 (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder)

①概念

- 食物を食べることに関心が乏しい、または何等かの感覚的な理由で食べることを避ける

- body imageの障害がないため、摂食症ではない

②症状

●体重減少

＊子どもの場合は成長の遅延、体重増加の不足

●栄養不足

●経口栄養補助食品への依存

③原因

●食物の外観や味、臭い等に対する感覚の過敏性

●喉に詰めてしまった、嘔吐等のショッキングな体験

④疫学

●小児期に多くみられる。男女差なし

＊以前は児童思春期の疾患とされていたが**成人発症も認められ**、DSM-5以降は食行動障害群に分類

⑤治療

●心理的介入や栄養学的介入

回避・制限性食物摂取症の症例

11歳 男性。最近健康的な食事をとっておらず、年齢から期待されるほどには身長や体重が十分に増加していないことを指摘され、母親と共に受診。

食べるものはポテトチップスとうどんに限定されている。肉や野菜は食べない。本人によると、食べ物を口にしたときの食感が問題で食べれるものと食べれないものがあるとのこと。受診時顔は青白く疲れた様子であった。学校でも友人とは遊べていない。身長は124cm、体重は18kgと年齢に比べるとかなり小さい。採血では鉄欠乏性貧血が認められた。

治療としては、現在の食習慣を続けることで生じるリスクとして、貧血の進行と微小元素欠乏症について説明。

本人もこれ以上やせたいとは思っておらず、摂取するメニューを拡大することには同意した。

鉄剤を内服しつつ、少しずつパンやおにぎりを食べるようにしていった。1年後、身長は132cm、体重は26kgまで増加した。

(「DSM-5を読み解く 1」P114～)